

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 4 Regelungen zum Umgang mit Noro-Viren	

Hauptziel innerhalb unseres Leitbildes ist es, dass sich Patienten in unserer Betreuung wohlfühlen. Dies bedeutet für uns auch, durch unser Handeln den Patienten nicht zu gefährden bzw. ihn in seiner gesundheitlichen Situation weiter zu stabilisieren. Hier eingebunden ist vor allem der geordnete und bewusste Umgang mit Hygiene, Desinfektion und Infektionsschutz.

Die nach stehenden Regelungen zum Umgang mit Noro-Viren lehnen sich an folgende Dokumente an:

- Rahmenhygieneplan für Pflegedienste Stand: 05/2003 (Verfasser: Landesgesundheitsamt Brandenburg, Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern, Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen, Thüringer Landesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz)
- Empfehlungen des RKI zum Umgang mit Noro-Viren Stand: Aktualisierte Fassung vom Juli 2008; Erstveröffentlichung im *Epidemiologischen Bulletin* 4/2000.

Erreger

Noroviren (früher als Norwalk-like-Viren bezeichnet) wurden 1972 durch elektronenmikroskopische Untersuchungen entdeckt. Sie gehören zur Familie der Caliciviridae. Gemäß einer Festsetzung des „International Committee on Taxonomy of Viruses“ (ICTV) erfolgt eine Unterteilung der humanen Caliciviren in die beiden Genera „Norovirus“ (NV) und „Sapovirus“ (SV).

Vorkommen

Noroviren sind weltweit verbreitet. Sie sind für einen Großteil der nicht bakteriell bedingten Erkrankungen des Magen-Darmtraktes bei Kindern (ca. 30 %) und bei Erwachsenen (bis zu 50 %) verantwortlich. Die Meldedaten des IfSG bestätigen, dass Kinder unter 5 Jahren und ältere Personen über 70 Jahre besonders häufig betroffen sind. Dies trägt dazu bei, dass Norovirus-Erkrankungen die überwiegende Ursache von akuten Gastroenteritis-Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen sind. Infektionen mit Noroviren können das ganze Jahr über auftreten, wobei ein saisonaler Gipfel in den Monaten Oktober bis März zu beobachten ist.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	I	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 4 Regelungen zum Umgang mit Noro-Viren	

Reservoir

Der Mensch ist das einzige bekannte Reservoir des Erregers. Der Nachweis von Caliciviren bei Tieren (Schweinen, Katzen und Kaninchen) steht derzeit in keinem erkennbaren Zusammenhang mit Erkrankungen des Menschen.

Infektionsweg

Die Viren werden über den Stuhl und das Erbrochene des Menschen ausgeschieden. Die Infektiosität ist sehr hoch, die minimale Infektionsdosis dürfte bei ca. 10–100 Viruspartikeln liegen. Die Übertragung erfolgt fäkal-oral (z.B. Handkontakt mit kontaminierten Flächen) oder durch die orale Aufnahme virushaltiger Tröpfchen, die im Rahmen des schwallartigen Erbrechens entstehen. Das erklärt die sehr rasche Infektionsausbreitung innerhalb von Altenheimen, Krankenhäusern und Gemeinschaftseinrichtungen.

Die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist in erster Linie die Ursache für die hohe Zahl an Norovirus-Infektionen. Infektionen können aber auch von kontaminierten Speisen (Salate, Krabben, Muscheln u.a.) oder Getränken (verunreinigtes Wasser) ausgehen.

Inkubationszeit

Die Inkubationszeit beträgt ca. 6–50 Stunden.

Dauer der Ansteckungsfähigkeit

Personen sind während der akuten Erkrankung hoch ansteckungsfähig. Unter pragmatischen Gesichtspunkten kommt daher im Hinblick auf die Vermeidung der Weiterverbreitung der symptomatischen Phase einschließlich der ersten 48 Stunden nach Sistieren der Symptome (d.h. bis zur sicheren Beendigung von Durchfall oder Erbrechen) die größte Bedeutung zu.

Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass das Virus in der Regel noch 7–14 Tage, in Ausnahmefällen aber auch noch über Wochen nach einer akuten Erkrankung über den Stuhl ausgeschieden werden kann. Daher ist auch nach der akuten Phase eine sorgfältige Sanitär- und Händehygiene noch weiter erforderlich.

Symptome

Noroviren verursachen akut beginnende Gastroenteritiden (Magen-Darm-Grippe), die durch schwallartiges heftiges Erbrechen und starke Durchfälle (Diarrhöe) gekennzeichnet sind und zu einem erheblichen Flüssigkeitsdefizit führen können. In einzelnen Fällen kann die Symptomatik auch auf Erbrechen ohne Diarrhöe oder auf Diarrhöe ohne Erbrechen beschränkt sein. In der Regel besteht ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl mit abdominalen Schmerzen, Übelkeit, Kopfschmerzen, Myalgien und Mattigkeit.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 4 Regelungen zum Umgang mit Noro-Viren	

Die Körpertemperatur kann leicht erhöht sein, meist kommt es jedoch nicht zu hohem Fieber. Wenn keine begleitenden Grunderkrankungen vorliegen, bestehen die klinischen Symptome etwa 12–48 Stunden. Auch leichtere oder asymptomatische Verläufe sind möglich.

Diagnostik

Eine Indikation zur Norovirus-Diagnostik besteht bei Patienten mit Durchfall (mit oder ohne Erbrechen), sofern keine andere Ursache für die Symptome bekannt ist. Insbesondere bei Häufungen von Durchfall und Erbrechen in Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäusern und Altenheimen muss frühzeitig eine Diagnose angestrebt werden. Bei untypischer Symptomatik oder Umgebungsuntersuchungen bei asymptomatischen Personen ist eine Diagnostik nicht indiziert. Die Diagnosestellung obliegt dem Arzt, stellen Pflegekräfte bei einem Patienten solche Symptome fest ist umgehend der Arzt zu informieren. Die Beobachtungen und Abstimmungen mit dem Arzt sind in der Pflegedokumentation zu hinterlegen.

Wichtigstes Mittel zu Unterstützung der Therapie

Die Therapie erfolgt symptomatisch durch Ausgleich des z.T. erheblichen Flüssigkeits- und Elektrolytverlustes. Eine kausale antivirale Therapie steht nicht zur Verfügung. Insbesondere bei betroffenen Kleinkindern und älteren Personen kann eine kurzzeitige Hospitalisierung notwendig sein. Der Einsatz von Antiemetika (Medikamente die Übelkeit und Brechreiz unterdrücken sollen) bei Patienten mit starkem Erbrechen kann erwogen werden.

Präventiv- und Bekämpfungsmaßnahmen

1. Präventive Maßnahmen

Eine Impfung steht nicht zur Verfügung. Wichtig ist die konsequente Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln in Altenheimen, Krankenhäusern, Gemeinschaftseinrichtungen und Küchen. Zur Vermeidung einer Übertragung durch kontaminierte Speisen sollten insbesondere Gerichte mit Meeresfrüchten gut durchgegart sein. Es gilt der für uns gültige freigegebene Hygieneplan mit dem Reinigungs- und Desinfektionsplan, sowie der hierin festgelegten Verwendung von Desinfektionsmitteln.

2. Maßnahmen für Patienten und Kontaktpersonen (s. auch Punkt 3)

Maßnahmen zum Schutz von Patienten und Kontaktpersonen sollten bei begründetem Verdacht sofort eingeleitet werden, d.h. ohne eine Laborbestätigung abzuwarten. Zur Vermeidung einer Übertragung auf fäkal-oralen Wege oder beim Erbrechen sind, insbesondere in der symptomatischen Phase, die Hygienemaßnahmen auszuweiten: Absonderung der erkrankten Personen, ggf. Kohortenisolierung/-pflege, Tragen von

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 4 Regelungen zum Umgang mit Noro-Viren	

Handschuhen, Schutzkittel, ggf. geeigneter Atemschutz zur Vermeidung einer Infektion im Zusammenhang mit Erbrechen, konsequente Händehygiene, Händedesinfektion, Desinfektion von patientennahen Flächen, Toiletten, Waschbecken, Türgriffen.

Zur Desinfektion sind nur Präparate mit nachgewiesener viruzider Wirksamkeit [1] zu verwenden. (www.rki.de > Infektionsschutz > Krankenhaushygiene > Informationen zu ausgewählten Erregern > Norovirus > FAQ).

Erkrankte Personen dürfen nicht in Lebensmittelberufen (definiert in § 42 IfSG) tätig sein. Eine Wiederaufnahme der Tätigkeit sollte frühestens 2 Tage nach dem Abklingen der klinischen Symptome erfolgen. In den folgenden 4–6 Wochen ist die Händehygiene am Arbeitsplatz besonders sorgfältig zu beachten. Bei Wiederauftreten der Symptomatik wird eine erneute Freistellung erforderlich. Eine ärztliche Vorstellung des betroffenen Mitarbeiters wird hiermit festgelegt, der Arzt soll feststellen ob der Mitarbeiter seiner Tätigkeit nachgehen kann.

3. Maßnahmen bei Ausbrüchen

Beim Auftreten von Norovirus-Erkrankungen in Krankenhäusern, Gemeinschaftseinrichtungen oder Altenheimen bildet die rasche klinische Abgrenzung auftretender Norovirus-Infektionen von anderen, z.B. durch Lebensmitteltoxine verursachten Gastroenteritiden (Magen-Darm-Erkrankung), die Grundlage einer effektiven Ausbruchsprävention. Wenn die typische Symptomatik und die epidemiologischen Merkmale auf eine Norovirus-Infektion hindeuten, sollten aufgrund der epidemischen Potenz präventive Maßnahmen rasch und konsequent ergriffen werden, auch ohne die Bestätigung durch virologische Untersuchungen abzuwarten.

Es empfiehlt sich, dass erkrankte Personen während der symptomatischen Phase keine betreuenden Tätigkeiten in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen ausüben.

Die wichtigsten empfohlenen Maßnahmen sind:

- Unterweisung der Patienten, der Angehörigen und des Personals hinsichtlich korrekter Händehygiene, Händedesinfektion mit einem viruzid wirksamen Händedesinfektionsmittel und Pflege der Patienten mit Einweghandschuhen, Schutzkittel und ggf. geeignetem Atemschutz zur Vermeidung einer Infektion im Zusammenhang mit Erbrechen;
- Durchführung einer sorgfältigen Händehygiene, Händedesinfektion mit einem viruzid wirksamen Händedesinfektionsmittel nach Ablegen der Einweghandschuhe und vor Verlassen des Zimmers;
- tägliche (in Sanitärbereichen ggf. häufigere) Wischdesinfektion aller patientennahen Kontaktflächen inkl. Türgriffen mit einem Flächendesinfektionsmittel mit nachgewiesener viruzider Wirksamkeit
- kontaminierte Flächen (z.B. mit Stuhl oder Erbrochenem) sofort nach Anlegen eines Atemschutzes gezielt desinfizierend reinigen;
- Pflegeutensilien personenbezogen verwenden und desinfizieren;

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	4	Verw., MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege Halle GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle: V.4	Bezeichnung des Dokumentes: Anlage 4 Regelungen zum Umgang mit Noro-Viren	

- Bett- und Leibwäsche als infektiöse Wäsche in einem geschlossenen Wäschesack transportieren und in einem (chemo-thermischen) Waschverfahren $\geq 60^{\circ}\text{C}$ zu reinigen;
- Geschirr kann in der Regel wie üblich maschinell gereinigt werden;
- Kontaktpersonen (z.B. Besucher, Familie) sind auf die mögliche Mensch-zu-Mensch-Übertragung durch Kontakt oder virushaltige Tröpfchen beim Erbrechen hinzuweisen und in der korrekten Händedesinfektion zu unterweisen;
- Die Aufbereitung genutzter Medizinprodukte ist zu beachten
- strenge Indikationsstellung bei akut Erkrankten hinsichtlich der Verlegungen. Der Krankentransport und die aufnehmende Institution ist vorab zu informieren. (siehe auch Expertenstandard „Entlassungsmanagement in der Pflege“)

Meldepflicht

Nach §§ 6,7 IfSG ist der Nachweis von Noro-Viren durch Labore und Ärzte meldepflichtig.

Weitere Maßnahmen

- jede Pflegekraft hat die Pflicht im Rahmen der Krankenbeobachtung auf die vorgenannten Symptome zu achten, bei Auftreten der Symptome ist sofort der Arzt und die PDL zu informieren.
- Pflegekräfte setzen die Festlegungen des Arztes im Rahmen der Therapie um (siehe Zusatz Organigramm), eigenständig ist hierzu sofort ein Trinkprotokoll anzulegen um eine geordnete Trinkzufuhr zu gewährleisten, das Problem ist in der Pflegeplanung zu berücksichtigen, akute Veränderungen sind im Pflegebericht zu beschreiben
- auf dem Stammblatt ist im oberen rechten Teil der Begriff „Noro“ mit rotem Stift aufzutragen, dieser ist durchzustreichen wenn die Erkrankung/Besiedelung durch den Arzt wieder ausgeschlossen werden kann
- im Team sind alle Pflegekräfte über den Befall mit Noro-Viren und seine Auswirkungen auf das pflegerische Handeln auf der Grundlage der hier vorgemachten Feststellungen aktuell zu belehren
- der Patient und seine Angehörigen ist nachweislich über das Vorhandensein von Noro-Viren und seine Auswirkungen zu belehren

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	5	Verw., MA